

Jairo Castañeda

Jairo Castañeda, 38 años. Casado con Liliana (35); dos hijos, Sofía (11) y Mateo (6). Tecnólogo en logística, supervisor de bodega en una empresa de distribución. Vive en Bogotá.

Tres sesiones: dos con Jairo y una con su esposa, autorizada por él. **Consentimiento firmado:** autoriza la evaluación, la entrevista a su esposa y el envío del informe **a su médica tratante**, no a otras personas.

Remisión de medicina general

Remisión a psicología

Paciente masculino de 38 años. Consulta por dolor en el pecho de características atípicas, ardor en la boca del estómago y dolor de cabeza de tipo tensional. Siete consultas en los últimos seis meses, dos de ellas por urgencias.

EKG normal en dos ocasiones. Enzimas cardíacas negativas en urgencias. Endoscopia digestiva: gastritis crónica leve, no erosiva. Función tiroidea normal. Valorado por cardiología: prueba de esfuerzo normal.

Sin hipertensión ni diabetes. Antecedente familiar: padre fallecido por IAM a los 61 años.

IDx: síntomas físicos persistentes sin causa orgánica que los explique. Descartar TAG o TDM.

Tratamiento actual: omeprazol 20 mg diarios; acetaminofén 500 mg cuando hay dolor.

Se solicita valoración por psicología y concepto sobre si existe un componente ansioso o depresivo que explique los síntomas, y si el paciente requiere manejo por psicología o remisión a psiquiatría.

Entrevistas con Jairo

Hace poco más de un año empezó con dolor en el pecho, «como un corrientazo que se queda ahí»; después vinieron el ardor en el estómago y los dolores de cabeza.

«Me hicieron de todo y todo sale bien. Pero el dolor está ahí. Uno no se inventa un dolor.»

«Yo no estoy deprimido. Lo mío es físico. Duermo mal es por el dolor.»

- Revisa el pulso en el reloj «varias veces al día, por si acaso» y de noche busca en internet los síntomas del infarto.
- En el último mes tuvo dos episodios de madrugada: corazón acelerado, sudor, falta de aire y «la sensación de que me iba a morir ahí mismo». Duraron unos veinte minutos.

- **Su padre** murió de un infarto hace un año y cuatro meses, a los 61, almorzando en la casa. Jairo le hizo reanimación mientras llegaba la ambulancia. Lloro al contarle: «Mi papá tampoco tenía nada. Todos los exámenes le salían bien».
- **Trabajo:** lo ascendieron hace ocho meses; tiene doce personas a cargo. Ha faltado cinco días este semestre por los síntomas.
- Dejó de trotar y de jugar con los niños «por miedo a que me dé algo». Lo único que mantiene es entrenar los sábados el equipo de microfútbol de Sofía: «Cuando estoy allá se me olvida todo. Ni me acuerdo del pecho».
- **Consumo:** cerveza cada quince días, «cuatro o cinco». No fuma desde hace seis años.
- Al hablar de su matrimonio agrega, bajando la voz: «Esto no tiene nada que ver, pero hace doce años tuve una relación con una compañera del trabajo anterior. Liliana nunca supo. Eso ya se acabó. Por favor, no lo vaya a poner en ningún papel».
- Niega ideas de muerte: «Yo lo que quiero es vivir, por eso me asusto tanto».

Entrevista a Liliana, su esposa

«Se levanta a las tres de la mañana a mirarse el pulso. Yo ya no sé si es el corazón o es la cabeza.»

- El cambio empezó después de la muerte del suegro: más irritable con los niños, cansado todo el tiempo. «Antes era el alma de las fiestas.»
- Jairo no quería venir porque «psicología es para locos».
- «En el trabajo lo buscan para todo: es el que sabe dónde está todo.»
- Al final agrega: «Yolanda, la hermana de él, me dijo que un compañero de Jairo le contó que lo han visto tomando en la bodega, en horas de trabajo. Yo nunca lo he visto borracho, pero uno no sabe».

Observación

Puntual y colaborador, aunque desconfía cuando se nombran la ansiedad o la depresión. Se sienta en el borde de la silla, se frota el pecho y revisa el pulso (cuatro veces en la primera sesión). Habla rápido, más lento al hablar del padre. Afecto ansioso, congruente; llanto breve. Pensamiento coherente, centrado en los síntomas y en el miedo al infarto. Orientado, atención conservada. Reconoce el malestar, pero lo atribuye solo a una causa física.

Pruebas

Prueba	Resultado	Cómo se lee
MMPI-2	36 ítems sin contestar , 31 de ellos después del ítem 370. Al entregarlo: «las últimas me dio pereza».	30 o más omisiones: el protocolo probablemente es inválido. Las escalas básicas salen de los primeros 370 ítems; las de contenido, de toda la prueba.
	Validez: Inconsistencia de respuestas variables (VRIN) 48 · Inconsistencia de respuestas verdaderas (TRIN) 55 · Infrecuencia (F) 62 · Infrecuencia posterior (Fb) 71 · Infrecuencia psicopatológica (Fp) 50 · Mentira (L) 56 · Corrección (K) 50	Puntuaciones T. T ≥ 65: elevación clínicamente significativa.
	Básicas: Hipocondría (Hs) 78 · Depresión (D) 72 · Histeria (Hy) 80 · Desviación psicopática (Pd) 55 · Masculinidad-feminidad (Mf) 48 · Paranoia (Pa) 58 · Psicastenia (Pt) 66 · Esquizofrenia (Sc) 60 · Hipomanía (Ma) 45 · Introversión social (Si) 62	
	Contenido: Ansiedad (ANX) 75 · Depresión (DEP) 74 · Preocupaciones por la salud (HEA) 82 · Dificultades en el trabajo (WRK) 66 · Indicadores negativos de tratamiento (TRT) 70 · las diez restantes, por debajo de 65	
BDI-II	24. Ítems más altos: sueño 3; pérdida de placer, agitación, energía, irritabilidad, concentración y cansancio 2. Pensamientos suicidas 0, fracaso 0, desvalorización 0.	0–13 mínima · 14–19 leve · 20–28 moderada · 29–63 grave
BAI	22. Más altos: palpitaciones, dolor de estómago, sensación de ahogo.	0–7 mínima · 8–15 leve · 16–25 moderada · 26–63 grave
AUDIT	6	0–7 bajo riesgo · 8–15 riesgo · 16–19 perjudicial · 20–40 probable dependencia

Exámenes médicos: electrocardiogramas, enzimas cardíacas, prueba de esfuerzo, función tiroidea, hemograma y perfil lipídico normales. Endoscopia: gastritis crónica leve, no erosiva.